

Vi khuẩn niệu không triệu chứng

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Vi khuẩn trong nước tiểu khi bạn hoàn toàn không có triệu chứng

Vi khuẩn niệu không triệu chứng (asymptomatic bacteriuria) có nghĩa là xét nghiệm nước tiểu phát hiện **vi khuẩn trong nước tiểu, nhưng bạn không có triệu chứng tiết niệu nào** — không rát, không tiểu gấp, không đau, không sốt. Tình trạng này rất phổ biến, đặc biệt ở người lớn tuổi, và ở hầu hết mọi người đây **không phải nhiễm trùng cần điều trị**. Tờ thông tin này giải thích tại sao bác sĩ có thể quyết định **không** kê kháng sinh cho bạn.

Điều này có nghĩa là gì

Nước tiểu không hoàn toàn vô khuẩn, và vi khuẩn lành tính có thể sống trong bàng quang mà không gây vấn đề gì. Chỉ phát hiện vi khuẩn qua xét nghiệm, tự nó, **không** có nghĩa là bạn đang bị bệnh. Tình trạng này chỉ trở thành **nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)** khi nó gây ra **triệu chứng** — như rát buốt, tiểu gấp, đau mới xuất hiện, hoặc sốt.

Tại sao thường không cần điều trị

Các hướng dẫn y tế lớn khuyến cáo **không** dùng kháng sinh khi phát hiện vi khuẩn nhưng không có triệu chứng, vì điều trị sẽ:

- **Không** giúp bạn cảm thấy tốt hơn (vì bạn đang cảm thấy bình thường)
- Gây ra **tác dụng phụ** của kháng sinh (phát ban, đau bụng, tiêu chảy do *C. difficile*)
- Thúc đẩy **kháng kháng sinh**, khiến việc điều trị nhiễm trùng trong tương lai khó hơn

Vì vậy, xét nghiệm nước tiểu "dương tính" ở người không có triệu chứng thường tốt nhất là theo dõi và không can thiệp.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Không triệu chứng

Không có bất kỳ triệu chứng nào.

Vi khuẩn niệu

Vi khuẩn hiện diện trong nước tiểu.

UTI

Nhiễm trùng đường tiết niệu — vi khuẩn *kèm* triệu chứng.

Cấy nước tiểu

Xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn từ mẫu nước tiểu.

Kháng kháng sinh

Vi khuẩn thích nghi và kháng sinh không còn hiệu quả.

Theo dõi chờ đợi

Quan sát thay vì điều trị khi chưa cần thiết.

VẬY TẠI SAO NƯỚC TIỂU CỦA TÔI LẠI ĐƯỢC XÉT NGHIỆM? Đôi khi nước tiểu được kiểm tra vì lý do khác, hoặc xét nghiệm được chỉ định trước khi triệu chứng rõ ràng. Nếu kết quả có vi khuẩn nhưng bạn không có triệu chứng, bác sĩ đang làm đúng theo bằng chứng khoa học khi không kê kháng sinh — không phải bỏ qua vấn đề của bạn. Có một số trường hợp cụ thể mà điều trị *được* khuyến cáo.

Khi nào CẦN điều trị

Có những trường hợp ngoại lệ quan trọng mà kháng sinh **được** khuyến cáo dù không có triệu chứng:

- **Thai kỳ** — điều trị bảo vệ cả bạn và thai nhi.
- **Trước một số thủ thuật tiết niệu** có nguy cơ gây chảy máu trong đường tiết niệu.

Ngoài hai trường hợp này, theo dõi chờ đợi là hướng đi an toàn và được khuyến cáo. Nước tiểu đục hoặc có mùi mạnh, nếu không kèm triệu chứng khác, **không** phải lý do để dùng kháng sinh.

Những dấu hiệu cần chú ý

Điều trị dựa trên **triệu chứng**, vì vậy hãy nhận biết các dấu hiệu cho thấy đã trở thành UTI thực sự:

- **Rát buốt** hoặc đau mới khi đi tiểu
- **Tiểu gấp hoặc tiểu nhiều lần** mới xuất hiện
- **Sốt, ớn lạnh, hoặc đau lưng/hông**

Điều tốt cần biết

- Ở người lớn tuổi, lần đầu đơn thuần thường **không** phải do UTI — cần kiểm tra các nguyên nhân khác trước.
- Nếu bạn có ống thông, một số vi khuẩn là bình thường và không được điều trị trừ khi có triệu chứng.
- Duy trì thói quen bình thường: uống đủ nước và không nhịn tiểu quá lâu.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Rát buốt, tiểu gấp, hoặc đau vùng chậu hay bụng dưới mới
- **Sốt, ớn lạnh, hoặc đau lưng/hông**
- Tiểu ra máu nhìn thấy được

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Vi khuẩn trong nước tiểu **không** kèm **triệu chứng** rất phổ biến và thường **không** cần điều trị — đó là lựa chọn an toàn, dựa trên bằng chứng.
2. Điều trị không giúp bạn cảm thấy tốt hơn và có thể gây tác dụng phụ và kháng kháng sinh.
3. Trường hợp ngoại lệ là thai kỳ và trước một số thủ thuật tiết niệu. Hãy gọi nếu bạn bị rát buốt, sốt, hoặc đau hông — đó có thể là UTI thực sự.